

Salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)

Méthodologie, préambule, définition & admission



Champ : recommandations pour la mise en place, la gestion, l'utilisation et l'évaluation d'une salle d'accueil des urgences vitales (SAUV, « salle de déchoquage ») au sein d'un service d'urgence. Élaborées à l'initiative de la SFMU, avec la Société francophone de médecine d'urgence, Samu de France, la SRLF et la SFAR. Reçu et accepté le 5 novembre 2003.

Méthodologie : ce texte est un référentiel organisationnel — critères minimaux d'architecture, d'équipement, de personnel et de procédures. Il ne comporte **aucun système de cotation** (pas de GRADE, pas de niveau de preuve individuel) : chaque recommandation est une norme collective, jamais gradée individuellement — restituée ici en listes et tableaux thématiques, jamais en chip de grade inventé.

1-2 — Préambule & définition

Bien que les urgences vitales ne constituent qu'une minorité des cas dans un service d'urgence, elles nécessitent une stratégie préétablie d'organisation des moyens humains et matériels. En l'absence d'élément réglementaire ou législatif précis concernant la SAUV, ces recommandations s'adressent à l'ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux des urgences, et aux responsables administratifs des établissements de santé.

La SAUV, ou salle de déchoquage, est un lieu d'accueil, au sein du service d'urgence, des patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle — dans le cadre d'un service d'accueil des urgences (SAU) ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (UPATOU). Les pôles spécialisés d'urgence (POSU) non pédiatriques déterminent, selon le type de patients pris en charge, si une SAUV doit être mise en place ; si tel est le cas, ces recommandations s'y appliquent. **Exclusion explicite de la source** : ces recommandations excluent la prise en charge des urgences pédiatriques, notamment les POSU pédiatriques (objet d'un texte complémentaire).

Principes directeurs d'une SAUV :

- ouverte 24 heures/24 ;
- ne correspond ni à un lit de réanimation ni à un lieu d'hospitalisation ;
- doit être libérée dès que possible ;
- polyvalente, médicochirurgicale.

Une structure accueillant déjà régulièrement des patients en détresse vitale (SSPI, unité de réanimation d'urgence) peut être utilisée comme SAUV — sans s'y substituer ni être substituée par elle — à condition d'être à proximité immédiate des urgences et de suivre l'ensemble de ces recommandations. Toute restructuration architecturale à venir devra intégrer la SAUV au sein du service d'urgence.

3 — Critères d'admission

L'admission dans une SAUV concerne tous les patients en situation de détresse vitale existante ou potentielle. La décision d'admission est prise par le médecin du service des urgences, et le cas échéant par l'infirmière d'accueil et d'orientation (IAO), le médecin du SMUR, ou le médecin régulateur du Samu — en s'appuyant sur des procédures cliniques, si possible à partir de scores de gravité validés et partagés. La prise en charge des urgences internes de l'établissement dans la SAUV doit rester exceptionnelle ; en l'absence d'alternative, la décision repose sur le médecin responsable de la SAUV ou son représentant désigné.

Salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)

Architecture & équipement Niveau 1



4 — Architecture

4.1 — Localisation : de préférence dans l'enceinte du service des urgences, sinon à proximité immédiate — emplacement réduisant les durées de transport vers le plateau technique (imagerie, réanimation, bloc opératoire).

4.2 — Accès : signalétique spécifique dès l'arrivée aux urgences ; couloirs de plain-pied entre sas d'arrivée, urgences et SAUV ; couloirs vers le plateau technique larges, permettant le croisement de brancards, sans mobilier entravant la circulation.

4.3 — Structure : un ou plusieurs emplacements (poste de soins pour un patient), nombre adapté à l'activité (passages, gravité, durée de séjour), avec au minimum :

- au moins 1 emplacement pour les services d'urgence non SAU ; au moins 2 pour les services > 15 000 passages/an et pour les SAU ;
- par emplacement : ≥ 2 prises oxygène, ≥ 1 prise air, ≥ 3 prises vide, ≥ 6 prises électricité (dont 2 sécurisées souhaitables), 1 système d'accrochage perfusions, 1 support pour appareils de surveillance/pousse-seringues ;
- surface SAUV $\geq 25 \text{ m}^2$ ($\geq 15 \text{ m}^2$ /emplacement hors rangements si plusieurs emplacements) ; rangements réservés exclusivement au matériel de la SAUV ;
- par pièce : ≥ 1 poste de lavage des mains, ≥ 1 dispositif d'affichage des radiographies, ≥ 1 plan de travail ;
- communication : ≥ 1 téléphone par pièce avec accès extérieur, ≥ 1 téléphone dédié à une liaison Samu, un dispositif d'appel de renfort sans quitter la pièce ; ordinateur avec accès réseau hospitalier et transfert d'images souhaitables ;
- alimentation électrique permettant le branchement d'appareils lourds (amplificateur de brillance, radiographie mobile, échographe) dans chaque pièce ; éclairage permettant les gestes techniques + éclairage mobile complémentaire ; possibilité d'obscurcissement pour les échographies.

5 — Équipement — Niveau 1 (services d'urgence non SAU)

Deux niveaux d'équipement minimum : Niveau 1 pour les services d'urgence non SAU, Niveau 2 pour les SAU (certaines structures non SAU doivent toutefois s'équiper selon les critères SAU, du fait d'une activité particulière et/ou d'un isolement géographique).

Recommandations par emplacement, sauf mention « PP » (par pièce) ou « PS » (par SAUV).

Domaine	Équipement minimal
Réanimation respiratoire	Fluides médicaux + bouteille O ₂ de secours (PP) ; ventilateur type transport (ventilation contrôlée/assistée, PEP, monitoring volumes/pressions, alarmes conformes) (PP) ; VNI souhaitable (PS) ; matériel d'intubation trachéale, insufflateur manuel + réservoir O ₂ , masques adaptés ; matériel d'intubation difficile (PP) ; aspirateur électrique + sondes protégées (PP) ; aspiration manuelle de secours (PP) ; monitoring SpO ₂ (courbes) + capnographe CO ₂ expiratoire (quantitatif souhaitable) (PP) ; débitmètre de pointe (PP) ; drainage thoracique (PP).
Réanimation cardiovasculaire	Électrocardioscope ; tensiomètre automatique + manuel (brassards adaptés) (PP) ; défibrillateur (PS) ; stimulation transthoracique (PS) ; ECG multipiste (PS) ; ≥ 2 pousse-seringues électriques ; matériel d'accès veineux périphérique/central préconditionné ; accélérateur-réchauffeur de perfusion (PP), autotransfusion (PS), garrot pneumatique (PS) ; kit transfusionnel (PP) ; mesure de l'hémoglobine (PP) ; aimant pour dispositifs implantés (PS).
Médicaments	Ensemble des médicaments pour défaillances respiratoires/circulatoires/neurologiques ; solutés de perfusion et de remplissage ; liste pré-établie connue de tous — analgésiques, sédatifs, antibiotiques, catécholamines, thrombolytiques, principaux antidotes.
Immobilisation	Matelas à dépression et/ou dispositif de transfert (PP) ; dispositifs d'immobilisation du rachis et des membres.
Divers	Brancard radiotransparent (réanimation, transport, contention) ; glycémie capillaire (PP) ; thermomètres dont un adapté à l'hypothermie (PS) ; réchauffement corporel (PP) ; sondes gastriques + poches de récupération (PP) ; drainage urinaire, y compris sus-pubien (PP) ; imagerie mobile + échographe (PS). Moyens propres pour mobiliser un patient ventilé avec tout son monitoring et ses dispositifs de traitement.

Salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)

Équipement Niveau 2, durée & collaboration



5.2 — Équipement — Niveau 2 (SAU)

Tous les moyens du Niveau 1 doivent être présents. Moyens supplémentaires : au moins un ventilateur dit « de réanimation », permettant plusieurs modes ventilatoires, en volume ou en pression (PS). Il est en outre souhaitable que la SAUV puisse disposer de la mesure de la pression artérielle invasive (PP) et de la fibroscopie bronchique (PS).

6 — Durée de prise en charge

La durée doit être la plus courte possible : le médecin de la SAUV doit avoir pour objectif la prise en charge immédiate, continue et coordonnée du patient, pour la remise en disponibilité rapide de la SAUV.

7 — Collaboration

7.1 — Relation avec le Samu-Smur : l'admission directe dans un service spécialisé est chaque fois privilégiée, mais les relations Samu/SAUV sont essentielles pour l'admission et l'orientation. Le Samu prévient la SAUV des difficultés d'aval (absence de lits de réanimation). Les patients amenés par le Smur sont systématiquement annoncés par le Samu, qui indique toute modification clinique ; le médecin du Smur peut à tout moment joindre le médecin de la SAUV via la régulation. Transmission de médecin à médecin et d'infirmier à infirmier, dossier complet et vérifié ; l'équipe du Smur ne quitte le patient qu'une fois la transmission effectuée et la sécurité assurée. Les transferts interhospitaliers médicalisés depuis la SAUV se décident entre le médecin de la SAUV et le médecin régulateur, même si l'établissement dispose d'un Smur propre.

7.2 — Relations et collaboration avec les autres services

Sous-section	Détail
7.2.1 — Anesthésie-réanimation et réanimations	Procédures établies avec le service d'anesthésie-réanimation et/ou les services de réanimation ; l'anesthésiste-réanimateur et/ou le réanimateur doit venir renforcer la SAUV à la demande de l'équipe. Si la SAUV est intégrée provisoirement dans une structure accueillant régulièrement des détresses vitales (SSPI, unité de réanimation d'urgence), un contrat entre les deux services doit en définir clairement le fonctionnement.
7.2.2 — Les consultants	La SAUV doit disposer des listes actualisées de gardes et astreintes de tous les spécialistes de l'établissement, et pouvoir les contacter directement sans passer par leur service d'origine. Ces médecins interviennent selon des modalités et délais définis à l'avance, par discipline, dans un règlement intérieur validé par les instances médico-administratives. Liste actualisée également des spécialistes non couverts par la permanence médicale de l'établissement.
7.2.3 — Services médicotéchniques	Accès privilégié à l'imagerie (priorités définies si le plateau technique n'est pas dédié aux urgences) et au(x) laboratoire(s), pour accélérer l'obtention des résultats ; biologie délocalisée en l'absence d'alternative.
7.2.4 — Services d'aval	Les patients de la SAUV sont acceptés en priorité et sans délai dès que leur départ peut être envisagé, pour maintenir la capacité d'accueil des urgences vitales. Les protocoles de transfert interne détaillent le personnel et le matériel engagés, sans compromettre la sécurité de la SAUV.
7.2.5 — Contractualisation	L'ensemble des collaborations nécessaires au fonctionnement en sécurité de la SAUV doit faire l'objet d'un protocole d'accord validé par les instances médico-administratives de l'établissement.

Salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)

Ressources humaines, procédures, évaluation & sources



8 — Ressources humaines

Le chef de service des urgences est responsable de l'organisation de la SAUV ou délègue cette responsabilité à un médecin de l'établissement ; un médecin nominativement identifié est en permanence mobilisable pour l'accueil et la prise en charge des patients.

8.1 — Formation de l'équipe : le personnel médical et paramédical (infirmier(e), aide-soignant(e) ou agent hospitalier) affecté à la SAUV doit avoir bénéficié d'une formation lui permettant de prendre en charge l'ensemble des situations menaçant le pronostic vital (procédures techniques et thérapeutiques), ainsi que d'une formation d'adaptation à l'emploi. Sur le plan du savoir-être, il doit savoir rester calme et communiquer avec l'équipe, les référents extérieurs et l'entourage du patient.

8.2 — Équipe soignante : effectif dépendant du flux de patients, mais au minimum un médecin, un(e) infirmier(e) et un(e) aide-soignant(e) ou agent hospitalier par SAUV, quels que soient l'heure et le jour. Ce personnel peut exercer d'autres fonctions mais doit pouvoir se libérer immédiatement — il est ainsi impossible, sauf circonstances exceptionnelles, que le médecin de la SAUV assure seul et simultanément la régulation Samu et/ou les interventions Smur. Le cadre infirmier supérieur des urgences est responsable de l'organisation paramédicale (ou délègue à un cadre/infirmier(e) nominativement identifié) ; un infirmier(e) et un aide-soignant/agent hospitalier au moins sont en permanence mobilisables.

9 — Procédures et protocoles

L'application de procédures clairement identifiées par chaque membre d'une équipe, sous la responsabilité d'un coordinateur, améliore la performance collective — la coordination n'est pas spontanée et demande une préparation : identification du rôle de chacun, standardisation des procédures, capacité de communication, et identification d'un chef d'équipe lorsqu'un événement survient.

Procédures devant être mises en place dans la SAUV :

- procédure d'alerte ; procédures d'appel des membres de l'équipe ; procédures de recours à un avis spécialisé ;
- préparation de la SAUV ; organisation du travail ; accueil du patient et sa prise en charge initiale ;
- protocoles de prise en charge des pathologies les plus fréquentes, fondés sur les données de la médecine fondée sur les preuves ;
- critères et modalités de transfert inter- ou intrahospitalier ; contenu des informations à transmettre avec le patient ;
- formation d'adaptation à l'emploi à la SAUV (médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s ou agents hospitaliers).

La liste nominative et actualisée de l'équipe affectée à la SAUV, comportant obligatoirement le moyen d'appel d'urgence du personnel, doit être affichée dans la SAUV. L'ensemble du matériel doit être prêt à une utilisation immédiate : vérifié après chaque utilisation et au moins une fois par jour (check-lists régulièrement mises à jour, vérification quotidienne par attribution nominative sous la responsabilité du cadre infirmier, apparaissant dans un registre ad hoc).

10 — Évaluation

Un registre de l'activité de la SAUV doit être mis en place, comportant au minimum : état civil et origine du patient ; mode d'admission ; horaires et durée de prise en charge ; motif d'admission ; actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés ; devenir et orientation du patient. Il est souhaitable de prévoir une analyse qualitative régulière des dossiers (démarche qualité) et une analyse collective par l'équipe des situations ayant conduit à un dysfonctionnement ou un décès.

Sources et traçabilité

Document source : « Recommandations concernant la mise en place, la gestion, l'utilisation et l'évaluation d'une salle d'accueil des urgences vitales (SAUV) ». Société francophone de médecine d'urgence (SFMU, à l'initiative), Samu de France, Société de réanimation de langue française (SRLF), Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR).

Groupe de travail : Dr P. Mardegan (SFMU, coordinateur), Dr L. Maillard (SRLF, secrétaire), C. Babatasi (SFMU), Pr P. Carli (Samu de France), Dr J.-L. Ducassé (SFMU), Pr J.-E. de La Coussaye (SFAR), Dr P. Goldstein (Samu de France), Dr P. Le Conte (SRLF), Pr B. Riou (SFAR), Dr B. Vermeulen (SFMU).

Version : reçu et accepté le 5 novembre 2003 ; publié dans Ann Fr Anesth Réanim 23 (2004) 850-855 et le Journal Européen des Urgences 2003;16:15165-15170.

Méthodologie : texte organisationnel/réglementaire, sans système de cotation ni niveau de preuve individuel — voir disclosure méthodologique en page 1.

URL source : <https://sfar.org/wp-content/uploads/2016/01/Recommandations-concernant-la-mise-en-place-la-gestion-l-utilisation-et-l-evaluation-d-une-salle-d-accueil-des-urgences-vitales.pdf>

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité du texte (préambule, définition, critères d'admission, architecture, équipement Niveaux 1 et 2, durée de prise en charge, collaboration, ressources humaines, procédures/protocoles, évaluation). Les 10 références réglementaires citées (décrets/circulaires 1991-2001) ne sont pas détaillées individuellement — se référer au texte intégral pour leurs références complètes.

Salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)

Ressources humaines, procédures, évaluation & sources



Avertissement — document de 2004 (recommandations de 2003) : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (dont les références réglementaires complètes) et n'est ni éditée ni validée par la SFMU, Samu de France, la SRLF ou la SFAR. Le cadre réglementaire français de l'accueil des urgences ayant évolué depuis 2003-2004, se référer aux textes réglementaires en vigueur et aux recommandations plus récentes le cas échéant.